

TEMA 2.2 • GINECOLOGÍA

Amenorrea

PERFIL EUNACOM 2.01.1.064
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Amenorrea

Definición

- **Amenorrea secundaria:** Ausencia de menstruación en mujer con menarquia previa:
- Ciclos regulares: ≥ 3 ciclos ausentes (o > 90 días)
- Ciclos irregulares: > 90 días sin menstruación
- **Amenorrea primaria:** Nunca ha menstruado:
- A los **15 años** con desarrollo puberal presente
- A los **13 años** sin desarrollo puberal (= también retraso puberal)

Amenorrea Secundaria

Causas

TABLA 2.2.1: TIPO VS EJEMPLOS	
TIPO	EJEMPLOS
Fisiológica	Embarazo (la más importante), lactancia, menopausia
Anovulación	SOP (la más frecuente causa patológica)
Hormonal	Hipotiroidismo, hiperprolactinemia
Hipogonadismo hipergonadotrópico	Falla ovárica (< 40 años = menopausia precoz)
Hipogonadismo hipogonadotrópico	Causa hipotalámica o hipofisiaria (Síndrome de Sheehan)
Uterina	Síndrome de Asherman (sinequias post-legrado)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN
Siempre descartar embarazo primero, independientemente de lo que diga la paciente.

Estudio Actual (todos los exámenes juntos)

- **βHCG** → descartar embarazo (siempre primero)
- **Estradiol + Progesterona** → evaluar hipogonadismo y anovulación
- **FSH + LH** → diferenciar origen ovárico vs. hipofisiario/hipotalámico
- **Prolactina + TSH** → descartar hiperprolactinemia e hipotiroidismo
- **Hormona Antimülleriana (HAM)** → reserva ovárica

Interpretación de Resultados

TABLA 2.2.2: ESTRADIOL VS FSH/LH			
ESTRADIOL	FSH/LH	PROGESTERONA	DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE
↓	↑ (altas)	↓	Hipogonadismo hipergonadotrópico → Falla ovárica
↓	↓ (bajas)	↓	Hipogonadismo hipogonadotrópico → Hipofisiario/hipotalámico
Normal/↑	Normal, LH ↑	↓	Anovulación → SOP (HAM elevada, acné, oligomenorrea)
Normal	Normal	Normal	Todo normal → Causa uterina (Síndrome de Asherman)

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Regla rápida: Ver el estradiol primero. - Estradiol **bajo** → hay hipogonadismo → ver FSH/LH para saber si es ovárico (↑) o hipofisiario (↓) - Estradiol **normal** y progesterona **baja** → anovulación (SOP) - Todo normal → causa uterina anatómica

Casos Clínicos Clave

TABLA 2.2.3: CASO CLÍNICO VS DIAGNÓSTICO	
CASO CLÍNICO	DIAGNÓSTICO
Mujer 35 años: estradiol ↓, FSH ↑, LH ↑, HAM ↓	Menopausia precoz (falla ovárica < 40 años)
Mujer 55 años: mismo perfil	Menopausia normal
Post-legrado, todo hormonal normal	Síndrome de Asherman (sinequias uterinas)
30 años, hemorragia puerperal → amenorrea + agalactia	Síndrome de Sheehan (panhipopituitarismo por infarto hipofisiario)
22 años, acné + oligomenorrea: estradiol normal, progesterona ↓, LH ↑, HAM ↑	SOP (anovulación)

NOTA CLÍNICA
Síndrome de Sheehan: Panhipopituitarismo por infarto hipofisiario secundario a hemorragia puerperal importante. Clínica: amenorrea + agalactia post-parto + fatiga (hipotiroidismo + hipocortisolismo).

Estudio Clásico (Obsoleto — útil para entender fisiopatología)

- **βHCG** → descartar embarazo
- **TSH + Prolactina** → descartar hormonal
- **Prueba de progesterona:** dar progestágeno (medroxiprogesterona) varios días y suspender
 - - (+) Menstrúa → **anovulación** (le faltaba progesterona) → SOP
 - - (-) No menstrúa → seguir estudio
- **Prueba estrógeno + progesterona:**
 - - (+) Menstrúa → **hipogonadismo** (le faltaban estrógenos) → pedir FSH/LH
 - - FSH/LH ↑ → hipogonadismo hipergonadotrópico → causa ovárica (falla ovárica)
 - - FSH/LH ↓ → hipogonadismo hipogonadotrópico → causa hipofisiaria/hipotalámica → RMN silla turca
 - - (-) No menstrúa → causa **uterina** → ecografía transvaginal (síndrome de Asherman)

Amenorrea Primaria

Definición: Sin menarquia a los 15 años (con desarrollo puberal) o 13 años (sin desarrollo puberal).

Enfrentamiento

TABLA 2.2.4: DESARROLLO PUBERAL PRESENTE VS CONDUCTA

DESARROLLO PUBERAL PRESENTE	CONDUCTA
Sí (thelarquia, pubarquia)	Prueba de progesterona → si (+): anovulación; si (–): seguir estudio
No	Todas las hormonas + cariograma (descartar Síndrome de Turner 45X0, insensibilidad androgénica)
Todo hormonal normal	Ecografía transrectal (en adolescentes, para preservar himen) → buscar malformaciones (himen imperforado, ausencia de útero)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Síndrome de Turner (45X0): amenorrea primaria + talla baja + fenotipo femenino + pterigium colli. Causa frecuente de amenorrea primaria sin desarrollo puberal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 17 años sin menarca, talla normal, caracteres sexuales secundarios ausentes (Tanner I). ¿Diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amenorrea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Amenorrea Secundaria
- Causas
- Estudio Actual (todos los exámenes juntos)
- Interpretación de Resultados
- Casos Clínicos Clave
- Estudio Clásico (Obsoleto — útil para entender fisiopatología)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMENORREA)

PREGUNTA 1

Mujer de 17 años sin menarca, talla normal, caracteres sexuales secundarios ausentes (Tanner I). ¿Diagnóstico más probable?

- A)** Amenorrea primaria por síndrome de ovario poliquístico
- B)** Amenorrea primaria — descartar hipogonadismo hipogonadotrófico o disgenesia gonadal
- C)** Embarazo no detectado
- D)** Amenorrea secundaria por estrés
- E)** Síndrome de Turner — tratar con progesterona

PREGUNTA 2

Mujer de 25 años, previamente con ciclos regulares, presenta amenorrea de 3 meses. Test de embarazo negativo. FSH y LH bajas, prolactina normal, TSH normal. ¿Diagnóstico más probable?

- A)** Falla ovárica prematura
- B)** Amenorrea hipotalámica funcional
- C)** Síndrome de ovario poliquístico
- D)** Hiperprolactinemia por adenoma hipofisario
- E)** Menopausia precoz

PREGUNTA 3

¿Cuál es la prueba más útil para diferenciar la amenorrea de origen ovárico de la amenorrea de origen central (hipotalámico/hipofisario)?

- A)** Ecografía ginecológica transvaginal
- B)** Medición de FSH y LH plasmáticas
- C)** Test de progesterona (prueba de privación)
- D)** Citología cervical (PAP)
- E)** Test de HCG sérico

RESUMEN: AMENORREA

1. β HCG → descartar embarazo (siempre primero) 2. Estradiol + Progesterona → evaluar hipogonadismo y anovulación 3. FSH + LH → diferenciar origen ovárico vs. hipofisario/hipotalámico 4. Prolactina + TSH → descartar hiperprolactinemia e hipotiroidismo 5. Hormona Antimülleriana (HAM) → reserva ovárica ::note Síndrome de Sheehan: Panhipopituitarismo por infarto hipofisario secundario a hemorragia puerperal importante. Clínica: amenorrea + agalactia post-parto + fatiga (hipotiroidismo + hipocortisolismo). :: 1. β HCG → descartar embarazo 2. TSH + Prolactina → descartar hormonal 3. Prueba de progesterona: dar progestágeno (medroxiprogesterona) varios días y suspender 4. Prueba estrógeno + progesterona: